

Endoscopic Urethroplasty (TUITMR)

WARWIKI

Impormasyon para sa Pasyente · Pagaayos ng peklat sa bladder neck nang walang hiwa sa labas

Ito ay pagaayos ng peklat na tisyu na pumipigil ng ihi sa bladder neck — o sa pinagsamang bahagi ng pantog at urethra pagkatapos ng operasyon sa prostate — sa pamamagitan ng scope lamang, nang walang hiwa sa labas. Binubuksan ng siruhano ang peklat at tinatahi ang malusog na lining ng pantog sa ibabaw nito, para gumaling ito nang bukas.

Tungkol sa Prosedurang Ito

Pagkatapos ng operasyon o radiation sa prostate, maaaring lumabas ang peklat na tisyu sa **bladder neck** na humahadlang sa daloy ng ihi. Ang simpleng paggupit ng peklat ay madalas na hindi sapat — muling nagsasara ito dahil nagpapagaling sa ibabaw ng hilaw na peklat.

Nilulutas ito ng **TUITMR** (transurethral incision with transverse mucosal realignment):

- Ang siruhano ay **gumugupit ng peklat** sa pamamagitan ng scope para buksan ang daanan.
- Gamit ang espesyal na **suturing tool**, ang malusog na lining ng pantog ay itinatahi sa ibabaw ng hiwa — parang flap repair, ngunit sa loob ng urethra.

Magagandang resulta: halos **9 sa 10** ay nananatiling bukas pagkatapos ng isang beses, at halos lahat pagkatapos ng pangalawa — na may mababang panganib ng bagong pagtagas ng ihi.

Ligtas Ba Ito?

Isinasagawa ito nang buo sa pamamagitan ng urethra, iniwasan ang mas malalaking operasyon. Maagang ebidensya ay maganda, kasama ang mababang panganib ng bagong pagtagas ng ihi. Ang mga panganib ay kinabibilangan ng pagdurugo, impeksiyon sa ihi (UTI), at posibleng muling pagsikip. Ito ay bago at espesyalisadong teknik.

MGA TERMINO

Bladder neck

Ang labasan ng pantog patungo sa urethra.

Bladder neck contracture

Peklat na pumipigil ng ihi sa bladder neck.

Anastomotic stenosis

Pagsikip ng peklat sa pinagsamang parte pagkatapos ng operasyon sa prostate.

Urethra

Ang tubo na nagdadala ng ihi palabas ng katawan.

Mucosa (lining)

Malusog na panloob na patong na itinatahi sa ibabaw ng peklat.

Cystoscope

Ang maliit na camera na ginagamit ng siruhano.

Incontinence

Pagtagas ng ihi — panganib na layuning mabawasan ng teknik na ito.

Catheter

Malambot na tubo na inilalagay sa urethra habang gumagaling.

MASAKIT BA? Isinasagawa ang pamamaraan sa ilalim ng anesthesia, kaya walang nararamdaman sa panahon nito. Pagkatapos, inaasahan ang banayad na pangingirot at bahagyang duguan na ihi sa loob ng ilang araw. May inilalagay na catheter sa maikling panahon. Karamihan ay umuuwi sa parehong araw o pagkatapos ng maikling pamamalagi.

Paano Maghanda (Bago ang Pamamaraan)

- Isinasagawa sa ilalim ng **general anesthesia** — sundin ang lahat ng tagubilin (pag-aayuno at kung anong gamot ang ipagpapaliban, kasama ang blood thinners).
- Ang **pagsusuri ng ihi** ay nagtatantsa ng impeksiyon — kailangang gamunan muna ang impeksiyon bago ang pamamaraan.
- Maghanda para sa **catheter sa maikling panahon**, at mag-ayos ng sasakyan pauwi.

Sabihin sa inyong care team nang maaga kung kayo ay:

- Umiinom ng **blood thinner**, o may kasalukuyang impeksiyon sa ihi
- Nagkaroon ng **operasyon sa prostate, radiation**, o naunang paggamot sa lugar na ito

Ano ang Nangyayari Habang Isinasagawa

- 1 Natutulog kayo sa ilalim ng anesthesia at bibigyan ng antibiotics.
- 2 Ang scope ay ipinasok hanggang sa peklat, at may guidewire na inilalagay para sa kaligtasan.
- 3 Ang peklat ay pinalawig at pinuputol para buksan ang daanan.
- 4 Gamit ang suturing tool sa pamamagitan ng urethra, ang malusog na lining ng pantog ay itinatahi sa ibabaw ng hiwa, at inilalagay ang catheter.

Pagkatapos ng Pamamaraan

- Umuuwi kayo sa **parehong araw o pagkatapos ng maikling pamamalagi**, na may catheter sa maikling panahon.
- Inaasahan ang **banayad na pangingirot at pinkish na ihi** sa loob ng ilang araw. Makatutulong ang pag-inom ng dagdag na tubig.
- Iwasan ang mabigat na pagbubuhat at pagsisikap** sa loob ng ilang linggo.
- Ang follow-up scope (mga **4 na buwan** pagkatapos) ay nagpapatunay na nananatiling bukas ang lugar.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Lagnat o panginginig
- Hindi makaihi**, lalo na pagkatapos matanggal ang catheter
- Bagong matinding **pagtagas** ng ihi
- Matinding pagdurugo, blood clots, o lumalaking sakit

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ito ay pagaayos ng peklat sa bladder neck nang walang hiwa sa labas — binubuksan ang peklat at tinatakpan ng malusog na lining para gumaling itong bukas, na may mababang panganib ng bagong pagtagas.
2. Para maghanda: sundin ang tagubilin sa pag-aayuno at gamot, gamunan muna ang impeksiyon, maghanda para sa catheter sa maikling panahon, at mag-ayos ng sasakyan.
3. Normal ang banayad na pangingirot at kaunting pinkish na ihi sa ilang araw; kinukumpirma ng follow-up scope ang tagumpay.